PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

EPIDEMIOLOGIA, VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IRAS E NA COMUNIDADE, DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E IMUNOPREVENÍVEIS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 10 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

10.1 Conceitos de epidemiologia

Epidemiologia estuda a distribuição e os determinantes dos estados de saúde e doença nas populações, aplicando esse conhecimento ao controle dos problemas de saúde.

Termo	Definição
Endemia	Ocorrência habitual de uma doença em determinada região, dentro do esperado
Epidemia	Aumento da ocorrência acima do esperado em determinada região e período
Surto	Epidemia localizada (mesmo local, como escola ou hospital), em geral com casos relacionados
Pandemia	Epidemia de grande extensão, atingindo vários países e continentes
Incidência	Número de **casos novos** em determinado período
Prevalência	Número **total de casos** (novos e antigos) existentes em determinado momento
Letalidade	Proporção de óbitos entre os **doentes** de determinada doença (gravidade)
Mortalidade	Proporção de óbitos em relação à **população total**

Cadeia de transmissão: agente etiológico → reservatório → porta de saída → modo de transmissão → porta de entrada → hospedeiro suscetível. Conceitos: **período de incubação** (da infecção até os primeiros sintomas), **período de transmissibilidade** (em que o agente pode ser transmitido), **portador** (abriga o agente sem manifestar a doença, mas pode transmiti-lo), **vetor** (ser vivo que transmite o agente, como o *Aedes aegypti*), **zoonose** (doença transmitida de animais ao homem, como raiva e leptospirose).

Níveis de prevenção (Leavell e Clark):

Nível	Objetivo	Exemplos
Prevenção primária	Promoção da saúde e proteção específica, **antes** da doença	Vacinação, saneamento, uso de preservativo, educação em saúde
Prevenção secundária	Diagnóstico precoce e tratamento imediato	Rastreamento (Papanicolau, mamografia), busca ativa de sintomáticos respiratórios
Prevenção terciária	Limitação de incapacidade e reabilitação	Fisioterapia pós-AVC, reabilitação de sequelas de hanseníase
Prevenção quaternária	Evitar intervenções desnecessárias (iatrogenia)	Evitar exames e medicações sem indicação

10.2 Vigilância em saúde

A Lei nº 8.080/1990 define **vigilância epidemiológica** como o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle. A **vigilância sanitária** é o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços. Integram ainda a vigilância em saúde a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador.

10.3 Notificação compulsória

Regida pela **Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017** (Anexo 1 do Anexo V, com atualizações periódicas, como a Portaria GM/MS nº 5.201/2024). A notificação é **obrigatória para médicos, outros profissionais de saúde** (incluindo a enfermagem) e responsáveis por estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Também deve ser feita a **notificação de caso suspeito**, sem aguardar a confirmação. A comunicação pode ser feita por qualquer cidadão.

- **Notificação imediata:** em até **24 horas**, à Secretaria Municipal de Saúde (e, em alguns casos, à Estadual e ao MS). Exemplos: acidente de trabalho grave ou fatal e com crianças e adolescentes, **raiva humana**, **sarampo**, **rubéola**, **poliomielite/paralisia flácida aguda**, **cólera**, **febre amarela**, **febre do Chikungunya em áreas sem transmissão**, **óbito por dengue**, **doença de Chagas aguda**, **difteria**, **botulismo**, **tétano** (acidental e neonatal), **hantavirose**, **meningite**, **malária fora da região amazônica**, acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, **violência sexual e tentativa de suicídio**, eventos de saúde pública, **evento adverso grave ou óbito pós-vacinação**, peste, varíola, influenza por novo subtipo.
- **Notificação semanal:** em até **7 dias**. Exemplos: **dengue** (casos), **hanseníase**, **tuberculose**, **HIV/aids**, **sífilis** (adquirida, em gestante e congênita), **hepatites virais**, leishmaniose, esquistossomose, **violência doméstica e outras violências**, acidente de trabalho com exposição a material biológico, leptospirose.

O **SINAN** (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) recebe as notificações por meio da **Ficha de Notificação** e da **Ficha de Investigação**.

10.4 Doenças imunopreveníveis

Doenças evitáveis por vacinação: sarampo, rubéola, caxumba, varicela, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, febre amarela, meningites (meningococo, pneumococo, Hib), tuberculose (formas graves), influenza, rotavírus, HPV e covid-19.

- **Sarampo:** febre alta, exantema maculopapular (início no rosto, em direção craniocaudal), tosse, coriza, conjuntivite e **manchas de Koplik** (na mucosa oral). Transmissão por aerossóis – **precaução por aerossóis**. Notificação imediata.
- **Coqueluche:** tosse paroxística seguida de "guincho" inspiratório; prevenção com DTP/pentavalente e dTpa na gestante. Precaução por gotículas.
- **Tétano:** não é transmitido de pessoa a pessoa; *Clostridium tetani* penetra em ferimentos. **Tétano neonatal** previne-se com a vacinação da gestante e o cuidado com o coto umbilical (álcool 70%). Sinais: trismo, riso sardônico, opistótono.
- **Poliomielite:** paralisia flácida aguda; o Brasil é livre de circulação desde 1989; vacinação com VIP.
- **Difteria:** placas pseudomembranosas branco-acinzentadas na garganta.
- **Meningite:** febre, cefaleia, vômitos, **rigidez de nuca** (sinais de Kernig e Brudzinski); na meningocócica pode haver **petéquias/sufusões** (meningococcemia). Precaução por gotículas nas primeiras 24 h de antibiótico.

Vacinas e conceitos: imunidade **ativa** (o próprio organismo produz anticorpos – vacina ou doença) × **passiva** (recebe anticorpos prontos – soro, imunoglobulina, anticorpos maternos via placenta e leite). Vacinas **vivas atenuadas**: BCG, tríplice viral, varicela, febre amarela, rotavírus, VOP. Vacinas inativadas/subunidades: VIP, hepatite B, pentavalente, influenza, pneumocócicas, meningocócicas, HPV. Intervalo entre duas vacinas vivas injetáveis não administradas no mesmo dia: **30 dias** (exceção: febre amarela e tríplice viral em menores de 2 anos não devem ser dadas no mesmo dia).

10.5 Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)

IRAS são infecções adquiridas após a admissão do paciente, manifestadas durante a internação ou após a alta, quando relacionadas à internação ou a procedimentos. Critério tradicional: infecção que se manifesta após **72 horas** da internação (ou antes, quando relacionada a procedimentos invasivos),

excetuadas as em incubação na admissão. Infecção de sítio cirúrgico pode surgir até **30 dias** após a cirurgia (ou até **90 dias** se houver implante).

Principais IRAS e medidas de prevenção (bundles):

IRAS	Prevenção
Infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter central (IPCS)	Higiene das mãos, barreira máxima na inserção, clorexidina alcoólica, desinfecção dos conectores, retirada precoce
Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV)	Cabeceira 30–45°, higiene oral, cuff 20–30 cmH2O, interrupção diária da sedação
Infecção do trato urinário associada a cateter vesical (ITU-AC)	Indicação precisa, técnica estéril na inserção, sistema fechado, bolsa abaixo da bexiga, retirada precoce
Infecção de sítio cirúrgico (ISC)	Banho pré-operatório, tricotomia com tricotomizador próxima à cirurgia, antibioticoprofilaxia em até 60 min antes da incisão, controle glicêmico e normotermia

A medida isolada **mais importante e simples** de prevenção das IRAS é a **higiene das mãos**. Microrganismos multirresistentes (MRSA, enterobactérias produtoras de carbapenemase – KPC, *Acinetobacter*) exigem **precaução de contato**.

■ 10.6 Orientações aos pacientes e familiares

Orientar sobre higiene das mãos, etiqueta respiratória (cobrir a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar), uso de máscara por sintomáticos respiratórios, adesão ao tratamento, vacinação, eliminação de criadouros do *Aedes*, cuidados com água e alimentos e restrição de visitas quando indicada.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Endemia, epidemia, surto e pandemia; incidência × prevalência; letalidade × mortalidade.
- Cadeia de transmissão; portador; vetor; zoonose.
- Níveis de prevenção (primária a quaternária).
- Vigilância epidemiológica × sanitária (Lei 8.080/1990).
- Notificação imediata (24 h) × semanal (7 dias); notificar caso suspeito; SINAN.
- Sarampo: notificação imediata e precaução por aerossóis.
- Imunidade ativa × passiva; vacinas vivas atenuadas.
- IRAS: 72 h; ISC até 30/90 dias; bundles; higiene das mãos.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Incidência é novidade, prevalência é estoque"**.
- **"Letalidade olha os doentes, mortalidade olha todo mundo"**.
- **"Surto é epidemia de endereço certo"**.
- **"Primária evita, secundária detecta, terciária reabilita, quaternária protege do excesso"**.
- **"Grave, raro ou explosivo = notifica em 24 h"** (sarampo, raiva, pólio, febre amarela, óbito por dengue).
- **"Vivas: BCG, febre amarela, tríplice viral, varicela, rotavírus"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Em determinado município, o número de casos de dengue em uma semana ultrapassou significativamente o esperado para o período. Essa situação caracteriza:

(A) endemia.
(B) epidemia.
(C) pandemia.
(D) prevalência.
(E) letalidade.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – endemia é a ocorrência dentro do esperado.

B) Correta – aumento acima do esperado em determinado local e período é epidemia.

C) Incorreta – pandemia atinge vários países e continentes.

D) Incorreta – prevalência é medida de frequência, não situação epidemiológica.

E) Incorreta – letalidade mede a proporção de óbitos entre os doentes.

QUESTÃO 02

A realização do exame de Papanicolau para detecção precoce de lesões do colo do útero é exemplo de ação de:

(A) prevenção primária.
(B) prevenção secundária.
(C) prevenção terciária.
(D) prevenção quaternária.
(E) promoção da saúde.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a primária atua antes da doença (como a vacina contra HPV).

B) Correta – rastreamento e diagnóstico precoce são prevenção secundária.

C) Incorreta – a terciária visa reabilitação e limitação de sequelas.

D) Incorreta – a quaternária evita intervenções desnecessárias.

E) Incorreta – promoção da saúde integra o nível primário.

QUESTÃO 03

Entre as doenças e agravos abaixo, é de notificação compulsória imediata (em até 24 horas):

(A) caso de hanseníase.
(B) caso de tuberculose.
(C) caso suspeito de sarampo.
(D) caso de hepatite viral crônica.
(E) caso de sífilis adquirida.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a hanseníase é de notificação semanal.

B) Incorreta – a tuberculose é de notificação semanal.

C) Correta – o sarampo é de notificação imediata, inclusive na suspeita.

D) Incorreta – as hepatites virais são de notificação semanal.

E) Incorreta – a sífilis adquirida é de notificação semanal.

QUESTÃO 04

O recém-nascido que recebe anticorpos da mãe pela placenta e pelo leite materno apresenta imunidade:

(A) ativa natural.
(B) ativa artificial.
(C) passiva natural.
(D) passiva artificial.
(E) inata adquirida.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a ativa natural ocorre quando o próprio organismo produz anticorpos após a doença.

B) Incorreta – a ativa artificial decorre da vacinação.

C) Correta – anticorpos prontos transferidos naturalmente da mãe caracterizam imunidade passiva natural.

D) Incorreta – a passiva artificial ocorre com soros e imunoglobulinas.

E) Incorreta – termo sem correspondência na classificação.

QUESTÃO 05

Considera-se a medida isolada mais importante e eficaz para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde:

(A) o uso rotineiro de antibióticos profiláticos em todos os pacientes.

(B) a higiene das mãos.
(C) o uso de luvas em todos os procedimentos, dispensando a higiene das mãos.
(D) a troca diária de todos os cateteres.
(E) o isolamento de todos os pacientes internados.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o uso indiscriminado de antibióticos favorece a resistência microbiana.

B) Correta – a higiene das mãos é a medida mais simples e eficaz.

C) Incorreta – as luvas não substituem a higiene das mãos.

D) Incorreta – trocas rotineiras sem indicação aumentam a manipulação e o risco.

E) Incorreta – o isolamento é indicado conforme o agente e o modo de transmissão.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: conceitos epidemiológicos; cadeia de transmissão; níveis de prevenção; vigilância epidemiológica e sanitária; notificação compulsória (imediata × semanal; SINAN); doenças imunopreveníveis; tipos de imunidade; IRAS e bundles; orientações à comunidade.

Quadro-resumo: notificação imediata em 24 h; semanal em 7 dias; IRAS após 72 h; ISC até 30 dias (90 com implante); vacinas vivas com intervalo de 30 dias.

Pegadinhas: esperar confirmação para notificar; confundir incidência e prevalência; achar que só o médico notifica; luva substituir a higiene das mãos.

Erros comuns: classificar rastreamento como prevenção primária; achar que tétano é contagioso.